

08 - 08- Les Ectoparasitoses - Pr. Hocar

Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui les ectoparasitoses cutanées. Ce cours intéressera les peaux et la gale humaine, qui constituent des motifs fréquents de consultations en dermatologie.

Ces deux dermatoses parasitaires, cosmopolites et contagieuses, ont une incidence croissante. Les peaux atteignent les enfants au nage scolaire, mais aussi les adultes dans des situations de précarité. La gale évolue par épidémie, notamment dans les maisons de retraite et les hôpitaux gériatriques.

Les difficultés diagnostiques et thérapeutiques sont variables selon l'âge et le terrain des patients. Sur le plan prise en charge, le Bénizoua de Bénizé, le Restomarc, le traitement de référence de la gale, les périthrines et le malathion offrent un large panel thérapeutique en matière de pédiculose. Au terme de ce cours, vous devriez être capables de diagnostiquer une gale et une pédiculose, et bien sûr, de savoir traiter une gale et une pédiculose.

Nous allons commencer par la gale. La gale humaine est due à la contamination de la peau par un acarien du genre *Sarcoptes scabiei*, variété *hominis*. La réaction de l'organisme contre les *Sarcoptes* et leur déjection expliquent la plupart des signes cliniques.

C'est une infection mondiale liée aux conditions d'hygiène régimentaires et à la promiscuité. Il faut noter que la transmission est inter-humaine et peut être par contact direct ou indirect. Les modalités de la transmission sont étroitement liées aux caractéristiques de l'acarien.

C'est un acarien femelle qui est responsable. Celui-ci a une bonne mobilité pour des températures de 25 à 30 degrés Celsius. Il peut se déplacer facilement à la surface de la peau de plusieurs centimètres par heure et il est tué très rapidement par des températures de 55 degrés Celsius.

Il perd sa mobilité en dessous de 20 degrés Celsius et meurt en 12 à 24 heures. La période d'incubation est de l'ordre de trois semaines. Elle est plus courte en cas de réinfestation.

Le cycle parasitaire a une durée de l'ordre de 20 jours mais en règle générale la population parasitaire est peu importante de l'ordre de dix semaines. La gale est contagieuse et se transmet dans l'immense majorité des cas par des contacts humains directs, intimes et prolongés, un cadre familial ou un cadre de couple. Elle est considérée comme une infection sexuellement transmissible.

La transmission indirecte par les vêtements ou la literie est plus rare sauf dans les formes hyperpyrétiques. Sur le plan clinique, la forme typique de la gale comporte les signes suivants. D'abord une prurit diffuse à reproductions nocturnes épargnant le visage.

Il a souvent un caractère conjugal ou familial, des lésions cutanées non spécifiques fréquentes dues au grattage et dont la topographie est évocatrice, surtout au niveau des espaces interdigitaux, face intérieure des poignets, coudes et émanchures antérieures, ombiliques au niveau des fesses, face interne des cuisses, ordins génitaux externes chez l'homme, mamelons et arioles chez la femme. À côté des lésions de grattage non spécifiques, on peut trouver des lésions spécifiques mais sont plus rares à rechercher systématiquement. D'abord les lésions scabieuses que vous voyez sur les deux photos.

Ce sont des lésions sumieuses de quelques millimètres de long, correspondent au trajet de l'acarien femelle dans la couche cornée de l'upiderme. Elles sont surtout visibles entre les doigts et sur la face intérieure des poignets et peuvent être mises en évidence par coloration à l'encre. Chaque scion contient les œufs pondus et à l'une des extrémités on peut trouver une discrète surélévation correspondant à la position de l'acarien femelle, ce qu'on appelle l'éminence acarienne.

D'autres lésions peuvent se retrouver surtout au niveau des organes génitaux externes, ce forme de papulonodules rouges ou violaces et prurigineux, parfois excoriés. Ça correspond à ce qu'on appelle les nodules scabieux à rechercher systématiquement en cas de gale, surtout au niveau des organes génitaux externes de l'homme. Sur cette photo, c'est une vue plus proche pour vous montrer les scions scabieux chez un patient qui présente une gale.

Sur cette photo, on peut voir sur les scions interdigitaux des lésions qu'on appelle les vésicules perlées, ça correspond à des petites têtes translucides reposant sur une base érythémateuse, à rechercher bien sûr sur les espaces interdigitaux. Là une autre photo pour vous montrer les nodules scabieux qui siègent avec prédilection sur les organes génitaux externes de l'homme. Ici on peut voir des nodules scabieux à localisation axillaire, surtout chez les nourrissons, aussi caractéristiques d'une gale.

Là c'est une figure qui résume les sites de prédilection des scabieuses, donc qu'on vient de voir, c'est surtout des espaces interdigitaux, les faces antérieures des poignets, les peaux, les émanchures antérieures, l'ombilique, les fesses, face interne des cuisses, les organes génitaux externes chez l'homme, maman et arrière maman, chez la femme, et bien sûr les nodules scabieux sur les organes génitaux externes de l'homme. On peut avoir d'autres formes cliniques à côté de la forme typique, d'abord la gale hyperkératosique, dite gale norvégienne. Le terrain particulier survient chez les immunodéprimés et les sujets âgés en collectivité.

La contagiosité est majeure en raison d'une prolifération parasitaire intense. Le prurit est plus souvent discrète, voire absence, ce qui est souvent la cause d'un retard diagnostique. L'aspect particulier avec une atteinte de tout le corps, y compris le visage, le cuir chevelu, les ongles qui sont vraiment atteints, et puis on peut avoir une érythrodermie avec des ongles hyperkératosiques.

Sur cette photo on peut voir une gale norvégienne, on voit l'aspect de lésions hyperkératosiques très importante avec une érythrodermie sous-jacente, et le tout évocateur d'une gale norvégienne à traiter bien sûr pour éviter la contagiosité très importante de cette forme clinique. Une deuxième forme clinique, c'est la gale du nourrisson. Elle est particulière par l'existence de lésions musculopistuleuses, palmaires et plantaires, des nodules scapieux périaxiaux et l'atteinte possible du visage.

Et puis il y a la gale des jambes propres, elle est caractérisée par des lésions qu'on dit fossé-lésionnelles, ça veut dire qu'elle est trempeuse parce que le plurite n'est pas aussi généralisé que la forme typique. Il faut y penser devant tout plurite persistant, le diagnostic repose sur l'anamnèse et la recherche des lésions spécifiques. Là des lésions musculopistuleuses plantaires dans le cadre d'une gale du nourrisson.

Ici des nodules scapieux axillaires et périaxiaux dans le cadre d'une gale du nourrisson. Sur le plan diagnostic, le diagnostic est avant tout clinique, il repose sur l'anamnèse devant un plurite familial à renforcement nocturne et l'éruption putanée de topographie évocatrice. Il n'y a pas de signe biologique spécifique.

La mise en évidence de l'acarien est difficile en dehors des formes profuses et hyperkératosiques. Il faut gratter un sillon avec un vaccin hostile, recueillir le matériel de ce sillon en traitement si possible, l'éminence acarienne. L'examen en microscope permet de voir les œufs au l'acarien adulte femelle, mais aussi le dermoscope putanétique qu'on peut utiliser en consultation et voir directement cet acarien femelle, surtout sur une éminence acarienne.

Cette diapositive vous montre les aspects qu'on peut retrouver au microscope. Là on voit à gauche l'aspect de l'acarien femelle et aussi à droite on peut voir l'acarien femelle, ses œufs et ses déjections recueillis sur un espace interdigital de la main. Les formes compliquées de la gale, il peut s'agir d'une surinfection avec un petit gélisation des lésions, tout un petit bout de l'adulte qui doit faire rechercher une gale.

Il peut s'agir aussi d'une eczématisation secondaire à la gale ou à son traitement. Il peut s'agir aussi d'un nodule poststabuleux, ce sont des lésions papulonodulaires progèneuses, rouges ou cuivrées, qui vont persister plusieurs semaines après un traitement efficace. Leur siège ubiquitaire, ils ne contiennent pas de sarcote et sont d'origine immunoallergique.

On arrive à la prise en charge de la gale. Le traitement fera appel à des traitements locaux, donc il faut traiter toutes les régions du corps, y compris le cuir, chevelu, le visage, s'il y a un doute sur leur atteinte. Et c'est un traitement qui se base sur le benzoate de benzine, la scabio, qui est disponible au Maroc, le lindin, le scabicide et les pérétrinomides pré-gales de façon intermittente.

Ils sont disponibles au Maroc. Il y a aussi des traitements par voie générale. Il y a l'ivermectine qu'on peut prescrire à la dose de 200 microgrammes par kilo par voie orale en prise unique chez

l'enfant de moins de 15 ans et la sécurité d'emploi n'est pas établie, donc à l'ID.

Et c'est un traitement qui n'est pas disponible au Maroc, donc si on le fait venir d'ailleurs. Il faut, à côté de ces traitements, il faut bien sûr insister que le traitement doit être simultané au sujet atteint et au sujet contact. Il faut un lavage du linge et des draps à 60 degrés.

Il faut bien sûr désinfecter le linge, les vêtements, la literie, la literie par artéria poudre ou du bygone poudre. Donc au niveau individuel, il faut traiter simultanément le sujet parasité et toute personne ayant eu contact intime avec le malade. En cas de gale commune à domicile, il faut prescrire un traitement local ou pérose le plus facile quand on a le nombre de personnes est très important.

En cas de gale profuse et il faut isoler le malade, prescrire un traitement local. Avoir une définition large des sujets contacts, prescrire une antibiotérapie en cas d'imputigénisation. Il faut traiter à nouveau les sujets ayant d'ici une clinique spécifique ou un examen parasitologique positif 8 à 15 jours après le traitement.

Il faut noter que certaines gales profuses nécessitent un traitement, une deuxième cure à 7 jours et puis à 15 jours. Les nodules post-scabieux ne constituent pas une indication à un traitement à nouveau. Ce sont des lésions immunoallergiques résiduelles.

Sur le plan environnemental, il faut laver les vêtements, les bras, les serviettes si possible en machine, à une température très élevée. Comme on a vu, le sacro-scabieux ne vit pas au-delà de 55 degrés. Ce n'est juste pas de désinfection de l'environnement.

On peut faire aussi une décontamination des lieux de vie à envisager en cas de gale profuse. Et bien sûr, quand on a une gale dans des maisons de retraite, dans des prisons, il faut bien sûr une stratégie de prise en charge en concertation avec les autorités d'hygiène sanitaire. Là, c'est une diapositive récapitulative de tout ce qu'on a vu en matière de diagnostic et de traitement de la gale.

Il faut noter que le diagnostic de la gale est évoqué devant toutes sortes de topographies évocatrices. Il peut s'agir d'un diagnostic difficile devant la gale des gens propres, devant des formes très profuses et hyperkeratosiques, devant la gale du nourissant, devant des bésécures parlementaires chez un nourissant qui doivent évoquer la gale, devant l'impétueux de l'adulte. Il faut penser, soit la gale, mais aussi à une licto-parasite, chose qu'on va voir.

En cas de gale, il faut traiter simultanément les sujets atteints, les contacts, sans oublier la désinfection du linge et de la literie. Il faut bien sûr inscrire un schéma thérapeutique précis et détaillé aux malades par écrit et bien sûr pas de traitement répété abusif. En cas de persistance du prurite après traitement, il faut penser à une réaction allergique, à une réinfestation, un prurite réactionnel ou un prurite psychogène pour les patients qui deviennent parasitophobes ou un traitement qui était insuffisant.

Là c'est un tableau qui résume les différentes molécules et produits dont on dispose chez nous au Maroc. Ce qui est en rouge, l'encadré en rouge, c'est le stroméctol, c'est à base d'ivermectin qui n'est pas disponible au Maroc. On a le Sprégal qui est de disponibilité intermittente et la Stabiol qui est souvent présente et le seul moyen dont on dispose pour traiter nos patients.

Donc vous voyez les formes galiniques, la durée de contact, les contreindications et bien sûr le dose selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'une femme enceinte, bien sûr à respecter à la lettre parce que c'est des produits qui peuvent s'avérer dangereux et irritants si on ne respecte pas la durée d'application et les doses à utiliser selon le terrain comme chez les enfants ou les personnes à fragilité, par exemple les femmes enceintes. Nous arrivons maintenant au TIRIAZ. Ce sont des infections cutanées externes dues à des arthropodes.

Ce sont des parasitoses obligatoires de l'homme. On en distingue trois espèces qui parasitent l'être humain. D'abord *Pudiculus humanus capitis*, donc ça atteint les cheveux.

Pudiculus humanus corporis, ça atteint le corps. Et puis *Pudiculus pubis anguinis* et ça atteint la région pubienne. Les facteurs favorisants sont la promiscuité, le mortigien, les guerres, le pot et le vecteur de tufus exanthématiques, chose qu'on doit tenir en tête si on a une fièvre la suite d'une infection variofthériase.

Nous allons commencer par les *Pudiculus* du cuir chevelu. Elle est due à l'infestation du cuir chevelu par le pouls de tête, *Pudiculus humanus variant capitis*. Il touche avec prédilection les enfants d'âge scolaire.

Sur le plan épidémiologique, le pouls adulte est hématophage. La femelle adulte prend les oeufs à raison de 10 à 20 par jour à proximité de l'émergence des cheveux. L'éclosion est assez rapide, une semaine, en raison de la pousse des cheveux.

Une lente située à plus de 1 cm de l'émergence est considérée comme non viable. Le pouls de tête ne transmet pas de maladies. L'épidémiologie se caractérise par une transmission interhumaine directe, contact des têtes, surtout chez les enfants de bas âge en période scolaire.

On peut avoir aussi une transmission interhumaine indirecte par les bonnets, les peignes et les brosses. Le diagnostic est basé sur la notion d'impureté du cuir chevelu, du flux ou la prodromulence rétro-auriculaire que vont s'étendre vers la nuque. L'examen clinique met en évidence des lésions de grattage du cuir chevelu de la nuque et ou des lésions croûteuses surinfectées associées parfois à des adénopathies cervicales.

Tout un petit bout de la nuque ou du cuir chevelu doit faire rechercher une pédiculose. Le diagnostic de certitude repose sur la découverte des pouls vivants visibles à l'œil nu, comme on voit sur ces deux photos, qui sont très mobiles. La présence de lentes vivantes oriente également le diagnostic.

Il s'agit de feux visibles à l'œil nu collés aux cheveux et ne coulissent pas le long de la tige pileuse et sont plus faciles à mettre en évidence dans les régions rétro-auriculaires. Comme on voit, c'est des lentes fixées sur les cheveux, sur les deux photos associées à des poux adultes, sur la deuxième photo. Là aussi, un signe très évocateur, c'est les lésions de grattage et les excoriations de la nuque et la partie haute du dos.

Chez un enfant, il faut bien sûr chercher les poux ou une pédiculose capitis. Cette photo, pour vous montrer l'aspect des lentes collées au poil à l'aide d'un microscope polarisé. À côté des fterias du cheveu, on peut avoir une fterias du corps.

Elle est caractérisée par un fluoride intermittent, des vacules érythémateuses de 3 à 4 mm, centrées par un point rouge central entouré par un allocure fluorique, mais aussi des strides linéaires de grattage siégeant sur la partie supérieure du dos, les épaules, les émanchures, au pourtour de la ceinture et des flancs. Mais aussi, on peut avoir un aspect de mélanodermie caractéristique d'une fterias du corps, surtout chez les sujets de précarité, les SDF, mais aussi les patients malades mentaux, par exemple, qui se délaissent. Là, c'est une photo qui montre une pédiculose corporelle avec des lésions non spécifiques de grattage et des cicatrices de lésions anciennes.

On peut voir aussi l'agent en cause, l'arthropode, sur les vêtements. Sur le plan épidémiologique, la pédiculose corporelle est beaucoup plus rare que la pédiculose du cuir chevelu. La transmission est inter-humaine directe pour miscuter des asiles de nuit, odieux aux vêtements.

Le poids circule sur le corps, le temps de se nourrir, il se réfugie ensuite dans les vêtements et pond ses oeufs sur les fibres. Le diagnostic du pterias du corps repose sur deux points. D'abord, l'aspect clinique des lésions cutanées, excoriées, pigmentées du corps, et la découverte de poux sur le corps lors du déshabillage ou sur les vêtements.

Le poux du corps est responsable de la transmission de maladies infectieuses, notamment la fièvre récurrente cosmopolite, tufus exemptématique, fièvre, des tranchées. Cette dernière a connu une reproduction récente dans les populations en condition de vie précaires des grandes métropoles urbaines et est responsable de cytissimie et d'endocardite. La découverte des lentes ou du poux sur les poils, les aisselles, les coutures, les vêtements, ceintures, des pantalons, couches, chemises, doit faire bien sûr retenir le diagnostic d'une stériase du corps.

On arrive à la stériase du pubis ou poux du pubis ou morpion. Donc il s'agit d'une ectoparasiteuse du arterius inguinalis. Le diagnostic repose sur la notion d'un fluoride pubien associé à des lésions de grattage qui peuvent être impétigénisées et s'accompagner d'adénopathies inguinales.

L'examen attentif révèle les poids adultes sous la forme d'une petite tâche grise près de l'orifice des poils. Les lentes sont à la limite de la visibilité sous la forme d'une petite masse arrondue

collée aux poils. Les poils des régions périanales, axillaires et pectorales peuvent être touchés.

La colonisation des cils est possible. Contrairement aux poux de la tête et aux poux du corps qui sont très mobiles, l'adulte vit accroché aux poils de la région génitale près de leur émergence et prend les oeufs sur la pilosité génitale, l'artériase est une infection sexuellement transmissible. Là, sur cette photo, on peut voir le pouls du pubis accroché aux poils avec l'aspect ardoisé à l'émergence du poil.

On peut les voir aussi sur les cils, donc ces deux localisations et caractéristiques du morpion. Là, on peut voir des lésions érythémateuses ardoisées de la région pubienne, mais aussi pourtout pubien, secondaire à une fteriasse du pubis ou du morpion. Là, c'est une vue microscopique du fterus inguinalis accroché aux poils et aussi une vue du pouls au microscope pour montrer l'aspect de cet arthropeute.

Là, c'est un diapos qui récapitule ce qu'on a vu sur les pudiculoses et pour distinguer trois formes de pudiculoses, d'abord celles de la tête, corporelles et publiennes. Les agents sont variables, donc pour la tête, c'est pudiculose humanis capitis, pour la région corporelle, humanus corporis et pour du pubis ou morpion, corporellus ou pubis. La contamination pour les trois est inter-humaine, directe ou indirecte, alors que celle du pubien est inter-humaine et souvent c'est considéré aussi comme une IST.

Les terrains pour la forme de la tête sont souvent les enfants d'âge scolaire. Pour les pudiculoses du corps, souvent c'est les SDF et des terrains de précarité et bien sûr les syncliniques sont plus vite selon la localisation et bien sûr les lentes et les ondes de grattage sur la région du cœur chevelu, sur la nuque et des adénopathies cervicales pour la pudiculose de la tête. Il doit y avoir un recombinaodermie, des lésions urticariennes et les poux retrouvées sur les vêtements pour la pudiculose du corps et bien sûr des lentes grisâtres et poux visibles à la base des poils, des fois atteintes des cils et des tâches ardoises et abdominales qui sont souvent évocateurs de fériass du pubis qu'il faut considérer comme une IST et conduire un bilan de l'IST associé bien sûr du sujet atteint et de son partenaire.

Le traitement se base essentiellement sur les dérivés de périthrine et de malactions, donc pour la pudiculose corporelle il faut assurer une décontamination du linge et de la literie est le plus souvent suffisante. Pour la fériass inguinale, les poux du pubis relèvent du même traitement que la pudiculose du cœur chevelu sachant que les poils peuvent être rasés et il faudra aussi dépister une autre IST associée et traiter les partenaires. Concernant les pudiculoses du cœur chevelu, à l'échelon individuel il faut traiter rapidement le sujet parasité avec un produit à la fois pudiculicide mais aussi l'anticide, présenter ce forme de solution, lotion à préférer à la crème, pas de traitement présentif, en cas d'examen de contrôle positif, ça veut dire qu'il y a des poux vivants à J2 ou à J2 il faut retraiter.

Donc à J2 si on a des poux changées de classe pharmacologique, ça veut dire qu'on a une

résistance des poux. Si à J12 on a réapparition des poux vivants, donc on n'a qu'à remettre le traitement initial. Les poux de tête sont à traiter en première intention avec des lotions à base de malations, cryodermes par exemple.

L'application réparée doit être maintenue pendant 12 heures puis suivie d'un shampoing non traitant, d'un rinçage à l'eau vinaigré et d'un peignage soigneux. Ce traitement doit être refait 8 jours plus tard pour tuer les lentes qui auraient éclos dans l'intervalle. La décontamination des vêtements et de la literie est à effectuer grâce à un lavage à 50 degrés par l'utilisation d'un aérosol type APAR.

L'éviction scolaire n'est pas systématique. Le traitement de la fratrie et de l'entourage n'est pas indispensable. Le traitement préventif notamment par des shampoings n'a aucun intérêt.

Les shampoings ne sont jamais curatifs. Il faut traiter les personnes parasitées vivant dans le foyer du cas index. Au niveau environnemental, il faut traiter les vêtements et la literie en cas d'infestation massive, lavage en machine, on peut faire un programme de cycle lent, des oreillers, des peluches, des bonnets.

La désinfection des locaux est inutile. Au niveau de la collectivité d'enfants, il faut pratiquer un examen du groupe par une personne formée et prévenir les parents par écrit, par exemple, examen des membres de la famille et les parents compris. Et bien sûr, si on a des cas dans l'entourage, il faut bien sûr les traiter.

Je vous remercie pour votre attention.